1

کیا شخص نشہ کے زیرِ اثر یا بے ہوش دکھائی دیتا ہے؟

نہیں

2 مرحلہ نمبر 2 پر جائیں

ہاں

طبی مشورہ

کسی شخص میں غیر واضح غنودگی اور سانس کی سست رفتار sedative کے شدید نشے کی حالت میں ہونے یا زیادہ مقدار میں استعمال سے ہو سکتی ہے۔

Sedative کے استعمال سے شدید نشے کی حالت کا شبہ

(Alcohol, Opioid, Other Sedatives)

- سانس کی نالی (airways)، سانس لینے کی رفتار اور سانس کی گردش کی جانچ کریں۔
- سانس لینے میں ابتدائی مدد فراہم کریں۔
- آکسیجن دیں۔

کیا شخص نیم بے ہوش یا بے ہوش ہے یا اسے سانس آنا بند ہو گئی ہے ؟

ہاں

- امدادی دیکھ بھال فراہم کریں ۔
- اہم علامات پر نظر رکھیں
- دم گھٹنے یا سانس بند ہونے سے بچاؤ کے لیے شخص کو کروٹ کے بل لیٹا دیں۔
- اگر آکسیجن دستیاب ہو تو فراہم کریں ۔
- نس کے ذریعے ری ہائیڈریشن پر غور کریں لیکن بے ہوشی کی حالت میں پینے کو کچھ نہ دیں۔
- مکمل صحت یاب ہونے یا ہسپتال منتقل ہونے تک اس شخص کو نگرانی میں رکھیں۔

نہیں

- آنکھ کی پتلیاں چیک کریں

(Check Pupils)

نارمل پتلیاں	سکڑی ہوئی پتلیاں
اوپیائیڈ کی زیادہ مقدار لینے کا امکان کم ہے ۔ شراب یا دیگر Sedatives کے بے تحاشہ استعمال ، ، یا دیگر طبی وجوہات پر غور کریں۔ (جیسے سر کی چوٹ، انفیکشن، یا خون میں گلوکوز کی کمی(Hyperglycemia)	اوپیائیڈ (Opioid) کے بے تحاشہ استعمال کا شبہ

- 0.4 سے 2 ملی گرام نالیگزون (Naloxone) نس، پٹھوں، ناک یا جلد کے ذریعے دیں۔
- سانس لینے کے لیے مدد فراہم کرنا جاری رکھیں۔

کیا اس شخص نے 2 منٹ کے اندر نالیگزون (Naloxone) پر رد عمل دیا؟

نہیں	ہاں
دوسری خوراک دیں اس شخص پر اس وقت تک نگرانی میں رکھیں جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائے یا ہسپتال منتقل نہ ہو جائے۔ !	1-2 گھنٹے تک نگرانی میں رکھیں اور ضرورت کے مطابق نالیگزون (Naloxone) کی خوراک دہرائیں۔ بے ہوشی کی حالت سے نکالنے کی کوشش جاری رکھیں اور تب تک نگرانی میں رکھیں جب تک پوری طرح ہوش میں نہ آجائے یا ہسپتال منتقل نہ ہو ۔ !

2

کیا شخص ضرورت سے زیادہ متحرک، ذہنی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے؟

نہیں

3 مرحلہ نمبر 3 پر جائیں

ہاں

A – D

جائزہ لیں اور اقدامات اٹھائیں۔

A

شخص نے حال ہی میں شراب پینا یا سکون آور نشہ (Sedative) کا استعمال کرنا چھوڑ ا ہے اور اب اس میں درج ذیل علامات میں سے کوئی بھی ظاہر ہو رہی ہے:

جھٹکے لگنا، پسینہ آنا، الٹی آنا، فشار خون اور دل کی دھڑکن میں اضافہ ، اور بے چینی۔

شراب ، بینزوڈائی زاپین یا دیگر سکون آور اشیا (Sedatives) چھوڑنے کی علامات کا شبہ

- نشہ چھوڑنے کی علامات کو کنٹرول کریں۔
  - اگر اس شخص کو جھٹکے لگ رہے ہیں، پسینہ آرہا ہے یا دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر جیسی اہم علامات میں تبدیلیاں آرہی ہوں تو ڈائی زیپم (Diazepam) 10-20 ملی گرام کھانے کو دیں اور اگر ممکن ہو تو ہسپتال یا نشہ کے اثر کو دور کرنے والے ادارے (detoxification (center) میں منتقل کریں۔
  - نشہ چھوڑنے کی علامات (جھٹکے لگنا، پسینہ آنا، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن میں اضافہ) کا مشاہدہ کریں اور ضرورت کے مطابق دوا کی خوراک دہرائیں۔
  - صرف شراب چھوڑنے سے آنے والی علامات کے لیے تھایامین (Thiamine) 100 ملی گرام 5 دن کے لیے دیں۔

!

اگر درج ذیل علامات موجود ہوں تو فوری طور پر ہسپتال منتقل کریں:

- دیگر سنگین طبی مسائل، جیسے جگر کے شدید اور طویل مدتی مرض کی وجہ سے ہونے والے اعصابی امراض (Hepatic Encephalopathy)، معدے سے خون بہنا یا سر پر چوٹ ۔
- دورے: سب سے پہلے ڈائی زیپا م (Diazepam) 10-20 ملی گرام، منہ ، نس یا ریکٹم (مقعد) کے ذریعے دیں۔
- منشیات کے استعمال سے ہونے والی بھولنے کی بیماری (Delirium): سب سے پہلے ڈائی زیپام 10-20 ملی گرام منہ ، نس یا ریکٹم (مقعد) کے ذریعے دیں۔ اگر علامات شدید ہوں اور ڈائی زیپا م (Diazepam) اثر نہ کرے تو، اینٹی سائیکوٹک (AntiPsychotic) دوا جیسے کہ ہیلو پیریڈول (haloperidol) 1 سے 2.5 ملی گرام منہ یا پٹھوں انجیکشن کے ذریعے دیں۔ نشہ چھوڑنے کی دیگر علامات (جھٹکے لگنا، پسینہ آنا، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن میں اضافہ جیسی اہم علامات میں تبدیلی) کا علاج ڈائی زیپا م (Diazepam) کے ساتھ جاری رکھیں۔

B

اس شخص نے حال ہی میں Stimulant، کوکین، ایمفیٹامین یا دیگر نشہ کا استعمال کیا ہے اور نیچے دی گئی علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو رہی ہے: آنکھ کی پھیلی ہوئی پتلیاں، ذہنی بے چینی، تشویش ، ، انتہائی پرجوش حالت، تیز خیالات، نبض کی رفتار اور بلڈ پریشر میں اضافہ۔

Stimulant کے استعمال سے شدید نشے کی حالت کا شبہ

(Suspect Acute Stimulant Intoxication)

- جب تک کہ شخص پرسکون اور نیم بے ہوش نہ ہو جائے، 5-10 ملی گرام ڈائی زیپام (Diazepam) منہ، نس، یا ریکٹم (مقعد) کے ذریعے خوراک کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے دیں ۔
- اگر ڈائی زیپام (Diazepam) سے نفسیاتی علامات کم نہ ہوں تو اینٹی سائیکوٹک ادویات جیسے ہیلوپیریڈو 1-2.5 ملی گرام منہ یا نس کے ذریعے دینے پر غور کریں۔ علامات ختم ہونے تک علاج کریں۔ اگر علامات برقرار رہیں تو سائیکوسس کی تشخیص کے لئے ریفر کریں۔
- جارحانہ اور/یا مشتعل رویے والے افراد کی دیکھ بھال کے لیے سائیکوسس کے ماہرین کو ریفر کریں ۔
- اگر شخص کو سینے میں درد ہو ، دل کی دھڑکن ایک منٹ میں 100 یا اس سے زیادہ ہو، یا دیگر اعصابی علامات ہوں تو ہسپتال منتقل کریں۔
- نشہ کے بعد کے مرحلے کے دوران، خودکشی کے خیالات یا اقدامات سے نمٹنے کے لیے با خبر رہیں۔ اگر خودکشی کے خیالات موجود ہیں تو اس کی باقاعدہ تشخیص کے لئے ماہر نفسیات کو ریفر کریں ۔

C

اس شخص نے حال ہی میں اوپیائیڈز کا استعمال بند کیا ہے اور نیچے دی گئی علامات میں سے کوئی بھی ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے جیسے: آنکھ کی پھیلی ہوئی پتلیاں، پٹھوں میں درد، پیٹ میں درد، سر درد، متلی، الٹی، دست یا پیچش (Diarrhea)، آنکھوں سے آنسو آنا اور ناک کا بہنا، تشویش / بے آرامی، پریشانی۔

اوپیائیڈ (Opioid) چھوڑنے کی شدید علامات کا شبہ

(Suspect Acute Opioid Withdrawal)

- اوپیائیڈ چھوڑنے کی علامات کا علاج کریں
  - 20 ملی گرام میتھاڈون دیں ۔ضرورت پڑے تو، 4 گھنٹے بعد 5-10 ملی گرام کی اضافی خوراک دیں۔
  - 4 سے 8 ملی گرام بیوپرینورفین دیں۔ اگر ضرورت پڑے تو 12 گھنٹے کے وقفے سے اضافی خوراک دیں۔
  - اگر میتھاڈون یا بیوپرینورفین دستیاب نہیں ہیں تو، کسی بھی اوپیائیڈ کو شدید صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی مورفین سلفیٹ
  - 10-20 ملی گرام ابتدائی خوراک کے ساتھ دیں اگر ضرورت پڑے تو 10 ملی گرام کی اضافی خوراک دیں ۔ الفا ایڈرینرجک ایگونسٹ alpha adrenergic (agonists) یعنی کلونائڈائن یا لوفیکسیڈائن پر بھی غور کریں۔
- مریض کی حالت بہتر ہو جائے تو SUB 2 پر جائیں.

D

دیگر طبی وجوہات اور اہم ذہنی، اعصابی اور نشہ آور اشیاء سے ہونے والے امراض کی جانچ کریں ۔

3

کیا شخص الجھن میں دکھائی دیتا ہے؟

نہیں

SUB1 تشخیص پر جائیں۔

ہاں

کیا کوئی ایسی طبی حالتوں پر مشتمل علامات موجود ہیں جو الجھن کی کر سکتی ہیں؟

- سر میں چوٹ
- خون میں گلوکوز کی کمی.
- نمونیا یا دیگر انفیکشن
- جگر کے طویل مرض کی وجہ سے ہونے والے دماغی
- امراض (Hepatic Encephalopathy)
- دیگر دماغی اور عصبی حادثات (CVA)

! ہاں

جسمانی علامات کے لیے اقدامات اٹھائیں اور شخص کو ہسپتال جانے کا مشورہ دیں ۔

نہیں

جائزہ لیں اور اقدامات اٹھائیں۔

A – C

A

شخص پچھلے ہفتے سے شراب پینا چھوڑ چکا ہے: الجھاؤ، وہم، تیز خیالات، تشویش، بے چینی، ہوش و حواس کھونا، جو یا تو عام طور پر تحریک دینے والے نشہ یا شراب (یا دیگر سکون آور نشہ) چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شراب یا Sedative چھوڑنے سے ڈیلیریم کا شبہ

(Suspect Alcohol or Sedative Withdrawal Delirium)

- اگر شخص میں شراب یا Sedative چھوڑنے کی دوسری علامات سامنے آرہی ہیں (جھٹکے، پسینہ آنا، نبض اور سانس کی رفتار یا بلڈ پریشر جیسی اہم علامات میں تبدیلی) تو ضرورت کے مطابق 10-20 ملی گرام ڈائی زیپام دیں۔
- ہسپتال منتقل کریں
- ڈیلیریم کا علاج بھولنے کی بیماری (Delirium) کے علاج کے لیے اینٹی سائیکوٹکس جیسے ہیلوپیریڈول 1-2.5 ملی گرام دیں یا انجکشن لگائیں.

B

شخص پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ شراب پی رہا ہے اور درج ذیل میں سے کوئی بھی علامات موجود ہے:

- (Nystagmus) آنکھوں کی غیر ارادی، تیز اور بار بار حرکت
- (Ophthalmoplegia) آنکھوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے والے ایک یا زیادہ عضلات کی کمزوری / فالج
- (Ataxia) بے ربط / بے ترتیب حرکات

ورنکی انسیفالوپیتھی کا شبہ

(Encephalopathy Suspect Wernicke's)

- 3-5 دن تک ت 100-500 ملی گرام تھایامین دن میں 2 - 3 بار نس یا پٹھوں کے ذریعے انجکشن کی صورت میں دیں۔
- ہسپتال منتقل کریں

C

شخص نے پچھلے کچھ دنوں میں سٹیملانٹس کا استعمال کیا ہے:

شخص نے پچھلے کچھ دنوں میں stimulants کا استعمال کیا ہے: پھیلی ہوئی پتلیاں، پر جوش رویہ، تیز خیالات، بے ترتیب سوچ، عجیب رویہ، نشے کا حال ہی میں استعمال، نبض اور بلڈ پریشر میں اضافہ، غصیلہ، بے ترتیب، یا پرتشدد رویہ

stimulants یا ہیلو سی نوجن کے نشے کا شبہ (Suspect Sedative or

(Hallucinogens Intoxication

- ڈائی زی پام 5-10 ملی گرام سانس یا مقصد (rectum) کے ذریعے اس وقت تک دیں. جب تک مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں آجائے.
- اگر نفسیاتی علامات ڈائی زی پام سے بہتر نہیں ہوتی تو اینٹی سائیکوٹک جیسے بلو پیریڈول ١ سے ٥ ملی گرام منہ یا پھٹوں کے ذریعے دیں.
- اگر نفسیاتی علامات برقرار رہیں تو psychiatrist کو ریفر کریں۔

طبی مشورہ

ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیے جانے والے اقدامات کے بعد، ضرورت کے مطابق SUB 1 تشخیص اور SUB 2 مینجمنٹ پروٹوکول 1 سے 6 پر جائیں۔